

第一章 常见症状的家庭识别与处理

1.1 发热

发热是指体温超过正常范围（腋下温度 $>37.2^{\circ}\text{C}$ ）。发热本身不是疾病，而是机体对抗感染的防御反应。

发热分级：

程度	腋下温度	处理原则
低热	$37.3^{\circ}\text{C} - 38^{\circ}\text{C}$	多饮水，物理降温，暂不用退热药
中度发热	$38.1^{\circ}\text{C} - 39^{\circ}\text{C}$	结合精神状态，必要时用药
高热	$39.1^{\circ}\text{C} - 41^{\circ}\text{C}$	使用退热药，密切观察
超高热	$>41^{\circ}\text{C}$	立即就医

家庭处理：

- **物理降温：**温水擦拭颈部、腋窝、腹股沟等大血管经过处，**禁用酒精擦浴**（酒精可经皮肤吸收导致中毒）。减少衣物包裹，利于散热。
- **药物退热：**成人可选用对乙酰氨基酚或布洛芬；儿童首选对乙酰氨基酚（每次 $10\text{-}15\text{mg/kg}$ ）或布洛芬（每次 $5\text{-}10\text{mg/kg}$ ）。两次用药间隔不少于 4-6 小时，24 小时内不超过 4 次。**避免交替使用两种退热药**，易导致剂量错误和肝损伤。
- **就医指征：**持续高热超过 3 天；体温 $>40^{\circ}\text{C}$ 且退热药无效；伴剧烈头痛、呕吐、皮疹、呼吸困难、意识改变；3 个月以下婴儿发热。

常见误区：

- 发热捂汗——会妨碍散热，可能导致体温更高甚至惊厥。
- 一发热就用抗生素——绝大多数发热由病毒引起，抗生素无效。
- 热退后立即停药——退热药仅缓解症状，病因未除可能反复发热。

1.2 咳嗽

咳嗽是呼吸道清除异物和分泌物的保护性反射。根据持续时间分为急性（<3 周）、亚急性（3-8 周）和慢性（>8 周）。

常见类型与鉴别：

类型	特点	常见病因
干咳无痰	刺激性、阵发性	上呼吸道感染早期、过敏、咳嗽变异性哮喘
湿咳有痰	咳嗽伴痰鸣音	支气管炎、肺炎恢复期、鼻后滴漏
夜间加重	躺下后咳嗽明显	鼻后滴漏、胃食管反流、哮喘
金属音样咳嗽	像小狗叫	喉炎、会厌炎（需紧急就医）

家庭处理：

- **多喝水：**稀释痰液，利于排出。
- **蜂蜜：**1 岁以上儿童及成人可睡前口服一勺蜂蜜，有助缓解夜间咳嗽（1 岁以下婴儿禁用，有肉毒杆菌中毒风险）。
- **增加空气湿度：**使用加湿器，维持湿度 50%-60%，减轻气道刺激。
- **避免镇咳药滥用：**有痰咳嗽不宜强力镇咳（如含可待因药物），以免痰液堵塞气道。干咳剧烈影响睡眠时，可在医生指导下短期使用右美沙芬。

就医指征：

- 咳嗽持续超过 3 周无好转。
- 咳出黄绿色脓痰、铁锈色痰或痰中带血。
- 伴胸痛、呼吸困难、高热不退、体重下降。

1.3 头痛

头痛病因复杂，多数为良性，但需警惕危险信号。

常见类型：

类型	特点	诱因
紧张性头痛	头部紧箍样压迫感，双侧，轻中度	精神压力、疲劳、姿势不良
偏头痛	单侧搏动性疼痛，中重度，伴恶心畏光	特定食物、睡眠紊乱、月经周期
丛集性头痛	单侧眼眶周围剧烈疼痛，伴流泪鼻塞	饮酒、血管扩张剂

危险信号（需立即就医）：

- 突发的“霹雳样”剧烈头痛（警惕蛛网膜下腔出血）。
- 伴发热、颈部僵硬、皮疹（警惕脑膜炎）。
- 伴一侧肢体无力、言语不清、视力改变（警惕脑卒中）。
- 50 岁后新发头痛或头痛性质明显改变。

日常管理：

- 记录头痛日记（发作时间、持续时间、诱因、缓解方式）。
- 规律作息，避免睡眠剥夺和过度睡眠。
- 偏头痛患者避免巧克力、奶酪、红酒等诱发食物。

1.4 腹痛

腹痛是腹部脏器疾病或功能性紊乱的信号。判断是否需要紧急处理，关键在于**疼痛的位置、性质和伴随症状**。

腹痛九分法定位：

区域	常见病因
右上腹	胆囊炎、胆结石、肝炎、肝脓肿
上腹部	胃炎、胃溃疡、胰腺炎、心肌梗死（下壁）
左上腹	脾梗死、胰腺炎、胃溃疡

区域	常见病因
脐周	小肠疾病、早期阑尾炎、肠系膜淋巴结炎
右下腹	急性阑尾炎、盲肠炎、女性右侧附件炎
下腹部	膀胱炎、盆腔炎、宫外孕破裂
左下腹	乙状结肠炎、左侧附件炎、结肠憩室炎

危险信号：

- 腹部**板状强直**（按压时腹肌极度紧张，像木板一样）——提示腹膜炎，需急诊手术。
- 疼痛向肩背部或会阴部放射——胆囊炎可向右肩放射，泌尿系结石向会阴放射。
- 伴呕血、便血、停止排气排便、黄疸。

家庭禁忌：

- **未明确诊断前，禁用止痛药**（如布洛芬、曲马多），以免掩盖病情、延误诊断。
- 怀疑阑尾炎或胰腺炎时**禁食禁水**，立即就医。

第二章 健康生活方式与疾病预防

2.1 合理膳食

中国居民膳食指南核心推荐（2022 版）：

1. **食物多样，谷类为主**：每日摄入食物种类不少于 12 种，每周不少于 25 种。谷类食物 200-300g/日，其中全谷物和杂豆占 50-150g。
2. **多吃蔬果、奶类、大豆**：蔬菜每日 300-500g，深色蔬菜占一半；水果 200-350g；奶及奶制品相当于液态奶 300ml 以上。
3. **适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉**：每日 120-200g，优先选择鱼和禽，少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品。
4. **少盐少油，控糖限酒**：食盐 <5g/日，烹调油 25-30g/日，添加糖 <50g/日

(最好 <25g)。成年男性酒精 <25g/日，女性 <15g/日。

常见慢性病饮食建议：

疾病	饮食要点
高血压	严格控盐 (<5g/日)，增加钾摄入 (香蕉、菠菜、豆类)
糖尿病	控制总热量，优选低 GI 食物 (燕麦、糙米、绿叶蔬菜)，定时定量进餐
高血脂症	减少饱和脂肪 (肥肉、黄油) 和反式脂肪 (糕点、油炸食品)，增加 ω -3 脂肪酸 (深海鱼、油)
痛风	限制高嘌呤食物 (动物内脏、浓肉汤、贝类海鲜)，多饮水 (>2000ml/日) 促进尿酸排泄

2.2 适量运动

推荐运动量：

- 成年人：每周至少 150 分钟中等强度有氧运动 (如快走、慢跑、游泳、骑车)，或 75 分钟高强度有氧运动 (如跑步、跳绳、球类比赛)，每周 2 次以上抗阻训练 (如哑铃、弹力带、深蹲)。
- 老年人：在平衡性和柔韧性训练基础上，保证每周 150 分钟中等强度运动，推荐太极拳、快走、健身操。

运动安全注意事项：

- 运动前充分热身 5-10 分钟，运动后拉伸放松。
- 避免空腹或饱餐后立即剧烈运动。
- 出现胸痛、呼吸困难、头晕、关节剧痛时立即停止，必要时就医。
- 感冒发热期间不宜剧烈运动，以免诱发病毒性心肌炎。

2.3 戒烟限酒

吸烟的危害：烟草烟雾中含有 7000 余种化学物质，其中至少 69 种为已知致癌物。吸烟可导致肺癌、喉癌、食管癌、膀胱癌等多种癌症，以及慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、冠心病、脑卒中。

戒烟获益时间线：

- 戒烟 20 分钟：心率、血压开始下降。
- 戒烟 12 小时：血中一氧化碳水平恢复正常。
- 戒烟 1-9 个月：咳嗽和气短减少，肺功能改善。
- 戒烟 1 年：冠心病风险降低 50%。
- 戒烟 5 年：脑卒中风险降至与非吸烟者相当。
- 戒烟 10 年：肺癌死亡率约为继续吸烟者的一半。

酒精的安全摄入：酒精是 WHO 列明的一类致癌物。若无法完全戒酒，男性每日酒精摄入量应 <25g（约等于啤酒 750ml、葡萄酒 250ml、高度白酒 50ml），女性减半。不存在“适量饮酒有益健康”的科学证据，最安全的饮酒量是 0。

2.4 心理平衡

心理健康是整体健康的重要组成部分。长期的精神压力、焦虑、抑郁可导致免疫力下降、心血管疾病风险增加、消化功能紊乱。

自我调节技巧：

- **正念呼吸：**每天花 5-10 分钟，安静坐好，专注于自己的呼吸，觉察气息进出身体的感觉，杂念出现时温和地回到呼吸上。
 - **规律生活：**固定起床和就寝时间，保证 7-8 小时睡眠。
 - **社交连接：**与家人、朋友保持良好沟通，参与群体活动。
 - **寻求专业帮助：**情绪问题持续超过 2 周且影响日常生活，应主动寻求心理咨询或精神科医生帮助。
-

第三章 疫苗接种常识

3.1 疫苗的作用原理

疫苗是将病原微生物（如细菌、病毒）经过减毒、灭活或基因重组等技术制成的生物制品。接种后，人体免疫系统会将其识别为“外来入侵者”，产生特异性抗体和记忆细胞。当真正病原体入侵时，免疫系统能迅速反应，阻止感染或减轻症状。

3.2 儿童免疫规划疫苗（一类疫苗）

疫苗名称	预防疾病	接种时间
卡介苗（BCG）	结核病	出生后 24 小时内
乙肝疫苗（HepB）	乙型病毒性肝炎	0、1、6 月龄
脊髓灰质炎疫苗（IPV/OPV）	小儿麻痹症	2、3、4 月龄，4 周岁加强
百白破疫苗（DTaP）	百日咳、白喉、破伤风	3、4、5、18 月龄
麻腮风疫苗（MMR）	麻疹、腮腺炎、风疹	8 月龄、18 月龄
乙脑疫苗（JE）	流行性乙型脑炎	8 月龄、2 周岁
流脑疫苗（Men）	流行性脑脊髓膜炎	6、9 月龄（A 群），3、6 周岁（AC 群）
甲肝疫苗（HepA）	甲型病毒性肝炎	18 月龄

3.3 成人推荐疫苗

疫苗名称	推荐人群	接种建议
流感疫苗	所有 ≥6 月龄人群	每年秋季接种 1 剂
肺炎球菌疫苗	≥65 岁老年人、慢性病患者	PPSV23 接种 1 剂，部分需 PCV13+PPSV23
带状疱疹疫苗	≥50 岁成人	重组疫苗（RZV）接种 2 剂，间隔 2-6 个月
HPV 疫苗	9-45 岁女性，9-26 岁男性	二价/四价/九价，共 3 剂
乙肝疫苗	未接种或抗体阴性者	0、1、6 月三剂，接种后查抗体
破伤风疫苗	所有成人	每 10 年加强 1 剂

3.4 疫苗接种常见问题

接种后发热怎么办？

多为低热（<38.5℃），持续 1-2 天，属正常免疫反应。多饮水、物理降温，体温 >38.5℃ 可服退热药。若高热不退或伴其他严重症状，需就医排查有无偶合感染。

哪些情况需暂缓接种？

- 急性发热性疾病（体温 >37.5℃）。
- 严重过敏反应史（对疫苗成分或上一剂疫苗过敏）。
- 免疫缺陷或正在使用免疫抑制剂者，禁种减毒活疫苗。
- 妊娠期妇女禁种减毒活疫苗（如麻腮风、水痘）。

第四章 家庭药箱与合理用药

4.1 家庭常备药清单

类别	推荐药物	用途与注意事项
退热镇痛	对乙酰氨基酚、布洛芬	发热、头痛、牙痛、关节痛。用，不超量。
抗过敏	西替利嗪、氯雷他定	过敏性鼻炎、荨麻疹。第二代嗜睡。
消化系统	蒙脱石散、口服补液盐 III	急性腹泻。蒙脱石与其他药间时。
皮肤外用	莫匹罗星软膏（抗细菌）、炉甘石洗剂（止痒）、氢化可的松乳膏（湿疹）	破损皮肤避免使用激素类软膏
外伤处理	碘伏棉签、无菌纱布、创可贴、医用胶带	碘伏不可与红汞（红药水）同
其他	电子体温计、镊子、冰袋、弹性绷带	

药箱管理：

- 每 3-6 个月清理一次，丢弃过期药品。
- 药品应存放于阴凉干燥处，部分需冷藏（详阅说明书）。
- 内服药与外用药分开放置，儿童药品与成人药品分开。
- 药箱应置于儿童无法触及处。

4.2 合理用药核心原则

1. **能不用就不用，能口服不肌注，能肌注不输液。**输液是高风险给药方式，仅用于急救、重症、无法口服者。
2. **不自行使用抗生素。**抗生素仅对细菌有效，对病毒无效。普通感冒、流感、咽痛多数为病毒感染，抗生素无效且会导致耐药。
3. **不随意增减剂量。**遵医嘱或说明书按时按量服药，尤其抗生素、降压药、降糖药，擅自停药可致病情反复或加重。
4. **注意药物相互作用。**如布洛芬与阿司匹林同服增加胃出血风险；头孢类抗生素与酒精同服可致双硫仑样反应（面红、胸闷、休克）。
5. **特殊人群用药谨慎。**孕妇、哺乳期妇女、儿童、老年人、肝肾功能不全者，用药前需咨询医生或药师。

4.3 识别药品有效期与储存要求

药品包装上标明的“有效期至 2026.04”表示该药品可用至 2026 年 4 月 30 日。过期药品禁止使用，不仅药效下降，还可能产生有害降解产物。

储存条件术语解析：

- **常温：**10-30℃。
- **阴凉处：**不超过 20℃。
- **冷藏：**2-8℃（冰箱冷藏室，不可冷冻）。
- **避光：**用不透光容器包装或置于阴暗处。
- **密闭/密封：**防止风化、吸潮、挥发或异物进入。

第五章 常见意外伤害急救常识

5.1 心肺复苏（CPR）

适用情况：患者无反应、无正常呼吸（或仅有濒死喘息）、无脉搏。

成人 CPR 操作步骤 (C-A-B 顺序):

1. **C (胸外按压, Compression)**: 将患者仰卧于硬质平面上。施救者跪于一侧, 双手掌根重叠置于两乳头连线中点 (胸骨下半部)。手臂伸直, 利用上半身重量垂直下压, 深度 5-6cm, 频率 100-120 次/分。每次按压后使胸廓完全回弹, 尽量减少中断。
2. **A (开放气道, Airway)**: 仰头抬颌法——一手压前额使头后仰, 另一手抬起下颌角, 清除口鼻可见异物。
3. **B (人工呼吸, Breathing)**: 捏住患者鼻翼, 正常吸一口气后口对口包严吹气 1 秒, 见胸廓隆起为有效。每 30 次按压后给予 2 次人工呼吸。若不愿或不能人工呼吸, 可只做持续胸外按压。

婴幼儿 CPR 要点:

- 胸外按压用**两指法** (双指按压两乳头连线中点下方) 或**双拇指环抱法**, 深度约 4cm (婴儿) 至 5cm (儿童)。
- 人工呼吸时用口对口鼻吹气。

何时停止: 患者恢复自主呼吸和心跳; 专业急救人员接手; 施救者精疲力竭; 环境变得不安全。

5.2 气道异物梗阻 (海姆立克急救法)

成人及 1 岁以上儿童:

施救者站于患者身后, 一脚置于患者两腿间呈弓步。双臂环抱患者腰部, 一手握拳, 拳眼对准患者肚脐以上、胸骨以下位置 (上腹部), 另一手包住拳头, 用力向内上方快速冲击, 重复直至异物排出。

自救: 同样握拳对准上腹部, 借助椅背、桌沿等固定物体边缘快速向上冲击。

1 岁以下婴儿:

采用**背部拍击 + 胸部冲击**交替法。将婴儿面朝下骑跨于施救者前臂, 头低脚高, 用手掌根部在婴儿**肩胛骨之间**快速拍击 5 次。若异物未排出, 翻转婴儿面朝上, 头低脚高, 用两指在婴儿**两乳头连线中点下方**快速按压 5 次。交替进行直至异物排出。

禁忌: 若患者能用力咳嗽、说话或呼吸, **不要干预**, 鼓励其自行咳嗽排出。只有在气道完全梗阻 (无法说话、呼吸困难、面色发绀、双手掐颈) 时方可使用海姆立克法。

5.3 烧烫伤紧急处理

冲、脱、泡、盖、送五字原则:

1. **冲**: 立即用流动凉水冲洗伤处 15-30 分钟, 直到疼痛明显减轻。**不可用冰块直接冰敷**, 会加重组织损伤。

2. **脱**：在冷水中小心脱去或剪开伤处衣物，不可强行撕脱，以免撕破水疱。
3. **泡**：疼痛明显者可继续在冷水中浸泡 15-30 分钟。
4. **盖**：用无菌纱布或清洁布单覆盖伤处，避免感染。
5. **送**：严重烧烫伤（深 II 度以上、面积较大、特殊部位如面颈会阴）需送医。

常见错误：

- 涂抹牙膏、酱油、蛋清、紫药水——不仅无效，还会干扰医生判断伤情，增加感染风险和清创难度。
- 直接挑破水疱——水疱皮是天然保护层，自行挑破易感染。

5.4 外伤出血止血

直接压迫止血法（适用于大多数外出血）：

用无菌纱布或干净布类直接按压伤口，持续至少 5-10 分钟，不要中途松开查看。若血液浸透纱布，不要移除原有纱布，直接在上面加层继续按压。

止血带使用（仅适用于四肢大动脉出血，直接压迫无效时）：

- 止血带应绑在伤口近心端（靠近心脏一侧）5cm 处，松紧以刚好止住出血为宜。
- **必须记录绑扎时间**，每隔 40-50 分钟放松 3-5 分钟，以免远端组织缺血坏死。
- 止血带是最后手段，非专业人员未经培训不建议轻易使用。

第六章 就医指南与医患沟通

6.1 何时应当就医

以下情况不建议居家观察，应及时就诊：

- 持续高热超过 3 天或超高热（ $>41^{\circ}\text{C}$ ）。
- 意识改变（嗜睡、烦躁、胡言乱语、昏迷）。
- 呼吸困难、口唇发紫。
- 剧烈胸痛、腹痛，或疼痛程度进行性加重。
- 突发严重头痛伴呕吐、颈部僵硬。
- 不明原因的体重短期内下降 $>5\%$ 。

- 咯血、呕血、便血（黑便或鲜血便）。
- 急性视力改变、言语不清、一侧肢体无力。

6.2 就诊前准备

1. **资料整理**：带齐身份证、医保卡、既往病历、检查报告、出院小结、正在服用的药品清单（或直接带药盒）。
2. **症状梳理**：就诊前简单梳理主要问题：什么时候开始？什么情况下加重/缓解？做过哪些处理？效果如何？
3. **列出问题清单**：把想问医生的关键问题写下来，避免当场遗忘。
4. **着装方便检查**：穿宽松易穿脱的衣物，避免连体衣、紧身衣。

6.3 与医生有效沟通

- **描述症状而非自我诊断**：说“我肚子疼”，而不是“我得了阑尾炎”。客观描述疼痛位置、性质（绞痛、钝痛、刺痛）、持续时间、诱发和缓解因素。
- **诚实告知用药史**：包括处方药、非处方药、保健品、中草药，以及有无药物过敏史。
- **不隐瞒不良生活习惯**：如吸烟、饮酒、熬夜等，这些信息对疾病诊断和治疗有重要参考价值。
- **有疑问当场问清**：药物的用法用量、注意事项、可能的副作用、何时复诊等，不清楚就问，避免回家后用药错误。

6.4 常见检查注意事项

检查项目	准备要求
抽血（生化、血糖、血脂）	需空腹 8-12 小时（可饮少量白水），前一晚清淡饮食，避免饮酒。
腹部 B 超（肝胆胰脾）	空腹 8 小时以上，减少胃肠气体干扰。
泌尿系/妇科 B 超	需憋尿，使膀胱充盈以清晰显示后方器官。检查前 1 小时饮水 500-800ml，不要
胃镜	空腹 8 小时以上，高血压患者晨起可用少量水服降压药。

检查项目

准备要求

肠镜

检查前 1-3 天进食少渣饮食，按医嘱服用泻药清洁肠道。

增强 CT/MRI

需禁食 4-6 小时，有过敏史、哮喘史、肾功能不全者需提前告知医生。体内有金（如心脏起搏器、金属支架、钢钉钢板）者禁做 MRI。